PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

Autos n.º	**0715595-88.2023.8.01.0001**
Classe	**Procedimento Comum Cível**
Requerente	**Élida Maria Jardim Teodoro**
Requerido	**UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**

Sentença

I)RELATÓRIO

Élida Maria Jardim Teodoro ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais e materiais cumulada com pedido de tutela provisória de urgência, em face de **UNIMED RIO BRANCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA**, para que lhe seja fornecido o medicamento denominado Evenity 90mg/ml (Romosozumabe) mais 02 (duas) seringas por mês preenchidas 1,17ml pelo período de 13 (doze) meses.

Relata ser titular do plano de saúde fornecido pela ré e apresenta osteoporose grave que vem evoluindo necessitando de alteração no protocolo de tratamento e, após analises dos exames, a médica requisitou o uso do medicamento indispensável para controlar a evolução da doença que lhe acomete com uso desta terapia anabólica óssea.

Ressalta que a ré recusou o pedido, alegando não ser responsável pelas medicações em tratamento em domicílio e aduz que a cobertura é apenas para medicamentos cobertos pelo rol da ANS, mas que a bula do medicamento indica que o tratamento deverá ser iniciado e supervisionado por médicos especialistas com experiência em tratamento da osteoporose não sendo, portanto, medicamento de uso domiciliar.

Assevera que a situação está cada dia mais grave, razão pela qual requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de medida liminar que imponha ao réu a obrigação de fornecer o medicamento e seringas. Requer, ao final, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré em danos morais e materiais.

A inicial veio instruída com procuração e documentos (pgs.16/48).

Instada a se manifestar previamente, a ré compareceu nos autos e apresentou a defesa prévia, onde informa que não tem obrigação de cobertura assistência para medicamentos não relacionados ao tratamento neoplásico (câncer) por ausência de previsão legal e contratual. Ademais, sustenta que o pedido liminar se confunde com o mérito da demanda. Ao final, pugnou pelo indeferimento da tutela provisória (pgs.53/109).

A petição inicial foi recebida e houve decisão deferindo os benefícios da assistência judiciária gratuita e a prioridade de tramitação. A tutela de urgência foi indeferida e determinada a realização de audiência de conciliação com a citação do réu (pp.112/121).

Os réus apresentaram habilitação dos patronos e preposto e adveio a realização de audiência de conciliação que restou frustrada (pp. 138/142).

A parte ré Unimed - Rio Branco Cooperativa de Trabalho Médico apresentou contestação (pp.129/128) acompanhada de documentos (pp.159/160).

Na peça de defesa, após breve síntese dos fatos e no mérito, discorre que não tem obrigatoriedade do fornecimento do medicamento convencional para tratamento não

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: (68) 3212-8448, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv3rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0715595-88.2023.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

oncológico nos termos do art.10, VI da Lei nº 9.656/98 com vedação expressa no contrato pactuado entre as partes fora do ambiente hospitalar de internação.

Relatou ser a aplicação do medicamento dispensada de ser realizada por enfermeiro ou médico podendo ser pelo próprio farmacêutico, paciente ou, ainda, pelo cuidador devidamente treinado, conforme a bula do medicamento.

Afirmou a observância da Súmula Vinculante nº 10 do STF, bem como da disponibilidade do medicamento pelo SUS mencionando o Enunciado nº 11 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

Frisa a inexistência de ato ilícito ou descumprimento contratual.

Mencionou a competência da ANS e rechaçou o dever de indenização por dano moral ou material mediante a ausência de qualquer conduta e do nexo causal, bem como ausência de prova do dano e falha na prestação de serviço.Por fim, requereu a improcedência dos pedidos da parte autora.

A parte autora foi intimada para manifestar-se acerca da contestação e apresentou réplica ratificando os seus pedidos iniciais (pp.189/205).

Intimados a especificarem eventuais provas que pretendam produzir (p.215), a parte autora requereu a produção de prova oral consistente na tomada de depoimento pessoal da autora e de testemunhas e a juntada de documentos (pp.216/217); o réu Unimed Rio Branco requereu pelo julgamento antecipado da lide (pp.224/226).

Instada a se manifestar em relação aos novos documentos anexados pela parte autora, a ré se manifestou refutando a tentativa de justificar que o medicamento seria de natureza hospitalar dada a inexistência de obrigação legal e contratual.

Após, os autos vieram conclusos.

II) FUNDAMENTAÇÃO

A presente ação foi ajuizada pela parte autora com o propósito inicial de compelir a parte ré à obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicação, bem como a condenação em danos morais e materiais..

Infere-se que as partes são legítimas, há interesse processual e estão presentes os pressupostos de existência e validade do processo, não havendo vícios a serem sanados. Assim, **declaro saneado o processo**.

Intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir, somente a parte parte autora requereu a dilação probatória, solicitando seu depoimento pessoal , além de realização de prova documental, porém, como não é dado à parte postular seu próprio depoimento (art. 385 do CPC), indefiro o pedido formulado pela autora e, em relação à produção de oral com a oitiva de testemunhas e prova documental, reputo-as desnecessárias, uma vez que as provas já produzidas já são suficientes ao julgamento do feito.

Admito que o direito à prova é um direito fundamental decorrente do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, estando ainda consagrado em dois Tratados Internacionais recepcionados pelo ordenamento pátrio (Convenção Americana de Direitos Humanos e Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos). Para seu efetivo exercício, não basta apenas se oportunizar às partes a produção da prova, devendo-se garantir também a participação em sua produção e o direito de se manifestar a respeito de seus resultados.

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: (68) 3212-8448, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv3rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0715595-88.2023.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

Porém, por vigorar no ordenamento pátrio o sistema de persuasão racional (art. 371 do CPC), torna-se o juiz o destinatário direto das provas produzidas no curso da ação, sendo-lhe dado indeferir a produção de provas inúteis (art. 370 do CPC), sendo exatamente esta a situação sob análise, em que a parte ré almeja produzir documental, desnecessária ao deslinde dos fatos postos a julgamento.

O indeferimento do pedido de dilação probatória não fere a garantia constitucional à produção da prova, tampouco enseja nulidade processual, eis que se funda no poder do juiz de impedir a realização de diligências inúteis.

Indeferida a dilação probatória, passa-se de pronto à análise do mérito.

MÉRITO

Trata-se de caso de julgamento antecipado da lide, nos termos no art. 355, I do Código de Processo Civil, porquanto as provas documentais produzidas pelas partes da relação processual são suficientes para dirimir os pontos nodais da controvérsia, passa-se de pronto à análise do mérito.

Já restou assentado que a relação entre as partes rege-se pelo Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a inversão do ônus da prova, face a hipossuficiência técnica do consumidor frente ao fornecedor.

É incontroverso que a autora é portadora de osteoporose grave e titular do plano de saúde firmado com a ré, ou seja, está demonstrada a relação contratual vigente entre as partes.

A ré aduz que ausência de obrigação legal e contratual em fornecer o medicamento requisitados pela médica.

Em que pese a incidência do estatuto consumerista e a necessidade de interpretação das cláusulas contratuais de maneira a não restringir direitos do consumidor, no caso em apreço a parte autora não logrou êxito em demonstrar a real existência da obrigação legal ou contratual no fornecimento do medicamento.

Como bem salientado por ocasião da decisão de pgs.112/121 no relatório médico à pgs.42/43, consta que a paciente já havia utilizado de outros medicamentos, porém sem resposta terapêutica, razão pela qual lhe fora prescrito o medicamento Romosozumabe (Evenity), em critério de urgência, dado ao risco de novas fraturas pelo prazo de 12 meses.

Veja o que diz o laudo de p. 42, subscrito pela Médica Dra. Ana Carolina Fonseca que requisitou o tratamento:

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: (68) 3212-8448, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv3rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0715595-88.2023.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ACRE
3ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco

RELATORIO MÉDICO

Paciente, 62 anos, com diagnóstico **Osteoporose com fratura de fragilidade** em punho esquerdo em 2022, sendo submetida a cirurgia na epoca. Iniciado prontamente terapia otimizada com suplementação com calcio e colecalciferol e bisfosfonado venoso (Acido Zoledronico – Denis), porém a paciente evoluiu com piora de massa óssea, principalmente em **coluna vertebral, apresentando T score atual < -3.6 neste sítio** , e em colo de femur T score : -3.1, classificando-a portanto como **Osteoporose e Muito Alto Risco de Fratura.**

Uma lesao que fratura osso pode danificar seriamente outros tecidos, incluindo pele, os nervos, os vasos sanguineos, musculos e os orgãos. Essas lesões podem complicar o tratamento da fratura e/ ou causar problemas temporários ou permanentes. Além dos danos nos vasos sanguíneos e nervos, outras complicações como síndrome compartimental, embolia gordurosa, infecções , problemas com articulações e cicatrizações, também são complicações que podem surgir após fratura óssea.

Devido atual quadro da paciente e não resposta a uso de bisfosfonados (medicação que age nos osteoclastos, impedindo reabsorção ossea), a mesma deve fazer uso de terapia **ANABÓLICA ÓSSEA**, ou seja capaz de aumentar a massa óssea, pois o medicamento age no osteoblasto (célula que forma massa óssea).

Diante do exposto, prescrevo terapia anabolica óssea, Romosozumabe(EVENITY) , em critério de urgência, em razão do elevado risco de novas fraturas , por 12 meses.

Prosseguindo com a análise da indicação médica, verifica-se que o medicamento é injetado de forma subcutâneo, nos termos do receituário de p. 43:

RECEITUÁRIO MÉDICO

Uso Subcutâneo Contínuo

1)EVENITY 90MG/ ML (ROMOSOZUMABE)---------- 2 SERINGAS / MÊS
SERINGA PREENCHIDA 1,17 ML
Aplicar 2 seringas SC 1 x/mês por 12 meses.

25/08/2023

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: (68) 3212-8448, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv3rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0715595-88.2023.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

Nesse sentido, denota-se que o medicamento prescrito, se revela adequado ao estado avançado de osteoporose da autora, de modo que a prescrição atende os requisitos para o seu fornecimento perante o **Poder Público (Saúde Pública)**, firmados em recurso repetitivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça para concessão da ordem : ***a)*** laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS ; ***b)*** incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e ***c)*** existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Trago do Superior Tribunal de Justiça:

> PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO. VEDAÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA USO OFF LABEL. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. Não cabe ao STJ definir os elementos constantes do laudo médico a ser apresentado pela parte autora. Incumbe ao julgador nas instâncias ordinárias, no caso concreto, verificar se as informações constantes do laudo médico são suficientes à formação de seu convencimento. 3.distribuídos na primeira instância a partir de 4/5/2018; (b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento. 5. Embargos de declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PARTE AUTORA. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. 1. Nos termos do que dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material. 2. No caso dos autos, não há vício a ensejar a integração do que decidido no julgado, pois, não constitui omissão o mero inconformismo com a conclusão do julgado, manifestado nas seguintes afirmações: que o STF tem admitido o fornecimento de medicamento não registrado na ANVISA; que a questão está sendo apreciada, em sede de repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, mas que ainda não foi concluído o julgamento; que o requisito de registro na ANVISA fere o princípio da isonomia. 3. Embargos de

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

> declaração rejeitados. PROCESSUAL CIVIL. ART. 494, I, DO CPC/2015. CORREÇÃO DE INEXATIDÃO MATERIAL. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO REPETITIVO. 1. O inciso I do art. 494 do CPC/2015 possibilita ao julgador a correção de ofício de eventuais inexatidões materiais no decisum. 2. No caso dos autos, a fim de evitar dúvidas, impõe-se a alteração do termo inicial da modulação dos efeitos. 3. Ante o exposto, de ofício, altera-se o termo inicial da modulação dos efeitos, do presente recurso especial repetitivo, para a data da publicação do acórdão embargado (4/5/2018). TESE FIXADA: A tese fixada no julgamento repetitivo passa a ser: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: **i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.** Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018. (destaquei) (EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)

Portanto, verifica-se que a parte autora preenche as exigências técnicas disponíveis nas Notas Técnicas 82110, conforme destaque:

> **Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia:** menor risco de fraturas
>
> **Recomendações da CONITEC para a situação clínica do demandante:** Não avaliada
>
> **Conclusão**
>
> **Tecnologia:** ROMOSOZUMABE
>
> **Conclusão Justificada:** Não favorável
>
> **Conclusão:** Há evidência de boa qualidade que o uso de romosozumabe em pacientes com alto risco de fratura sem tratamento prévio, previne novas fraturas quando comparado com placebo e com tratamento ativo (alendronato). Não localizamos estudos que tenham avaliado esta mesma questão em pacientes que apresentaram fratura quando em tratamento com alendronato (condição clínica da parte autora).
> Além disso, o custo do medicamento é excessivo. Em pelo menos duas avaliações econômicas de países de alta renda (Canadá e Reino Unido), foi considerado não custo-efetivo, levando a incorporação no primeiro cenário somente condicionado à redução de custo.
>
> **Há evidências científicas?** Sim

Contudo, no presente feito não estamos a discutir o fornecimento de medicamentos pelo Sistema de Saúde Pública, mas de contratação de assistência à saúde suplementar. Tratam-se de naturezas jurídicas absolutamente distintas.

O medicamento é aplicado de forma subcutâneo e não exige qualquer intervenção da Operadora de Saúde para aquisição e aplicação, pois se assim o fosse exigido, todo o portador de diabetes teria direito de receber o medicamento por parte da Operadora de Saúde, o que seria incompatível para o equilíbrio contratual.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

Quanto a não obrigatoriedade do fornecimento do medicamento por parte da Operadora de Saúde, torna-se importante citar as recentes decisões do Superior Tribunal de Justiça:

> RECURSO ESPECIAL Nº 2169482 - SP (2024/0342419-9)
> EMENTAPROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO PREJUDICADO.
> 1. Ação de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais.
> 2. Segundo a jurisprudência desta Corte, é lícita a negativa de cobertura de medicamento para tratamento domiciliar que não se enquadre em nenhuma das hipóteses de cobertura determinadas pela Lei 9.656/1998. Precedentes.
> 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
> 4. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
> 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
> DECISÃO
> Examina-se recurso especial interposto por EDERLI VIOTTO, fundamentado, exclusivamente, na alínea "c" do permissivo constitucional.
> Recurso especial interposto em: 03/06/2024.
> Concluso ao gabinete em: 17/09/2024.
> Ação: de obrigação de fazer cumulada com compensação por danos morais, ajuizada pelo recorrente em face de GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, na qual requer o custeio do medicamento "Prolia (Denosumabe) 60mg", a ser aplicado a cada seis meses, necessário ao tratamento de sua doença (osteoporose).
> Sentença: julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a recorrida a custear o medicamento solicitado, bem como ao pagamento de R$ 1.164,65 (mil cento e sessenta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) a título de danos materiais.
> Acórdão: deu provimento à apelação interposta pela recorrida, para julgar improcedentes os pedidos, nos termos da seguinte ementa:
> Apelação cível. Plano de saúde. Cobertura para medicamento Prolia, prescrito para tratamento de osteoporose. Danos morais e materiais.
> Sentença de procedência parcial. Recursos da paciente e da operadora.
> Preliminar. Reiteração de argumentos da contestação não impede o

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

conhecimento do recurso. Argumentos relacionam-se com os fundamentos da sentença. Princípio da dialeticidade não violado. Preliminar rejeitada. Preliminar. Cerceamento de defesa. Perícia. Rejeição. Prova não requisitada no momento processual oportuno. Preclusão. Não há alegação de que a prescrição médica é inadequada; tampouco cabe ao perito indicar tratamentos alternativos eventualmente existentes no rol. Tarefa que cabe à ré. Mérito. RN 465/21 da ANS define que medicamento domiciliar é aquele "prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde" (art. 17, VI). Esse é o caso dos autos.
Medicamento injetável por via subcutânea, sem necessidade de supervisão de profissional de saúde. Aplicação pode ser feita pelo próprio paciente, conforme instruções da bula. Não há cobertura obrigatória para medicamentos de uso domiciliar, exceto antineoplásicos e os destinados a tratar os efeitos adversos do tratamento de câncer. Inteligência do Art. 10, VI da Lei 9656/98.
Ausência de condições financeiras do paciente. Questão não é oponível às operadoras de plano de saúde. Interpretação analógica da exceção prevista na Lei 9656/98 descabida no caso dos autos. Autora não é portadora de doença grave. Tratamento envolve aplicações de custo relativamente alto, porém semestrais. Sentença reformada.
Apelação da ré provida. Não provida apelação da autora.
Recurso especial: Sustenta que o medicamento é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida e que, portanto, não se trata de medicamento domiciliar. Afirma a existência de dissídio jurisprudencial, tendo em vista que o medicamento foi considerado de uso ambulatorial em acórdãos paradigmas, afastando, portanto, a incidência dos arts. 17, VI, da RN 465/21 da ANS e 10, VI, da Lei 9656/98.
RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE.
- Da ausência de obrigação de a operadora de plano de saúde custear medicamento para tratamento domiciliar As duas Turmas que compõem a Segunda Seção do STJ já decidiram que, independentemente da discussão a respeito da natureza do rol da ANS, "é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)" (REsp 1.692.938/SP, 3ª Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021; e REsp 1.883.654/SP, 4ª Turma, julgado em 08/6/2021, DJe de 02/8/2021).

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

Nesse mesmo sentido, colhe-se os seguintes precedentes: AgInt no AgInt no REsp 2.071.979/SP, 4ª Turma, DJe de 2/5/2024; AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1.860.635/MS, 3ª Turma, DJe de 20/12/2023;
AgInt no REsp 1.859.473/RJ, 4ª Turma, DJe de 13/6/2023; AgInt no AREsp 2.310.638/TO, 4ª Turma, DJe de 14/9/2023; AgInt no REsp 2.031.280/MG, 3ª Turma, DJe de 9/3/2023; AgInt no AgInt no REsp 1.939.779/SP, 3ª Turma, DJe de 19/10/2022; AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1.964.771/RS, 3ª Turma, DJe de 8/9/2022; AgInt no AREsp 2.058.484/MG, 4ª Turma, DJe de 26/8/2022; AgInt no REsp 1.981.905/MG, 3ª Turma, DJe de 17/8/2022; AgInt no REsp 1.973.853/SP, 4ª Turma, DJe de 11/5/2022; e AgInt no REsp 1.939.973/MG, 3ª Turma, DJe de 29/9/2021.
No particular, aduz o acórdão recorrido que se trata de medicamento de uso domiciliar, não listado no rol da ANS ou nas hipóteses legais de custeio, conforme se extrai (e-STJ, fls. 211/512):
No mérito, a negativa está baseada na alegação de que o medicamento é domiciliar, bem como não consta no rol da ANS.
Quanto ao primeiro ponto, a RN 465/21 da ANS define que medicamento domiciliar é aquele "prescrito pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde" (art. 17, VI). Esse é o caso dos autos.
Consultando a bula do medicamento Prolia (Fls. 340), verifica-se que se trata de substância injetável por via subcutânea e não requer a supervisão de profissional de saúde. Há, inclusive, instruções para autoadministração do medicamento. Ou seja, o próprio paciente pode fazer a aplicação sozinho.
Assim sendo, a aplicação em farmácia, ou clínica, ocorre por escolha e conveniência do paciente e não desnatura a característica domiciliar do medicamento.
Nos termos da lei 9656/98, não há cobertura obrigatória para medicamentos de uso domiciliar, exceto antineoplásicos e os destinados a tratar os efeitos adversos do tratamento de câncer (art. 10, VI).
Como o medicamento Prolia destina-se a tratar osteoporose, a negativa da ré é legítima.
O argumento de que a autora não tem condições financeiras de arcar com o tratamento não é oponível às operadoras de plano de saúde, vez que prestam serviço mediante pagamento e nos limites do contrato.
É certo que, em algumas situações excepcionais, a Jurisprudência adota uma interpretação analógica do art. 10, VI da Lei 9656/98, para conceder a tutela a medicamentos não neoplásicos. Porém, no presente caso, essa interpretação não tem cabimento, vez que a autora não é portadora de doença grave, cuja definição está no art. 1.048, I do

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

Código de Processo Civil.
Dessa forma, verifica-se que o entendimento adotado pelo TJ/SP encontra-se em consonância com a orientação desta Corte, sendo forçoso concluir que não há obrigatoriedade de custeio pela operadora do plano de saúde de medicamento domiciliar não incluído no rol da ANS.
Logo, não merece reforma o acórdão recorrido, com fundamento na Súmula 568/STJ.
- Do reexame de fatos e provas Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere a constatação de que se trata de medicamento de uso domiciliar, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
- Da divergência jurisprudencial Além disso, a incidência da Súmula 7 desta Corte acerca do tema que se supõe divergente, qual seja, a caracterização do fármaco pleiteado como medicamento de uso domiciliar ou ambulatorial, impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República. Isso porque, a demonstração da divergência não pode estar fundamentada em questões de fato, mas apenas na interpretação do dispositivo legal. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.974.371/RJ, Terceira Turma, DJe de 22/11/2023 e REsp n. 1.907.171/RJ, Quarta Turma, DJe de 11/1/2024.
Forte nessas razões, com fundamento no art. 932, III e IV, "a", do CPC, bem como na Súmula 568/STJ, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial e, nessa extensão, NEGO-LHE PROVIMENTO.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional imposto ao advogado da parte agravada em virtude da interposição deste recurso, majoro os honorários fixados anteriormente em 10% sobre o valor da causa (e-STJ fls. 512) para 12% (doze por cento).
Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar sua condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º, do CPC.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 30 de setembro de 2024.
MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora
(**REsp n. 2.169.482, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 01/10/2024.**)

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

RE nos EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1982152 - SP (2022/0018470-9)
EMENTA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO PARA OSTEOPOROSE. USO DOMICILIAR. COBERTURA. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
DECISÃO
Trata-se de recurso extraordinário interposto por IVAN DOMINGUES DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado (fl. 497):
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. OSTEOPOROSE. USO DOMICILIAR. EXCLUSÃO DE COBERTURA. POSSIBILIDADE. AUTOADMINISTRAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. "É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.
Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021)" (AgInt nos EREsp 1.895.659/PR, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/11/2022, DJe de 9/12/2022).
2. Hipótese na qual, conforme expressamente consignado pelas instâncias ordinárias, o contrato firmado pelas partes prevê a exclusão da cobertura de medicamentos para uso domiciliar, e o medicamento prescrito para o tratamento de osteoporose pode ser adquirido diretamente pelo paciente para autoadministração em seu ambiente domiciliar, não se afigurando indevida, portanto, a negativa de cobertura pelo plano de saúde.
3. Agravo interno provido.
Os embargos de declaração opostos na sequência foram rejeitados (fls. 556-563).
A parte recorrente alega a existência de repercussão geral da matéria debatida e de contrariedade, no acórdão impugnado, aos arts. 1º, III, 5º, caput, 6º, caput, 196 e 197 da Constituição Federal.
Nesse sentido, argumenta ter havido ofensa aos princípios da isonomia e da segurança jurídica, porque o seu irmão, portador dos mesmos problemas de saúde, teria obtido pronunciamento jurisdicional diverso.
Afirma nunca ter requerido o medicamento em questão para uso domiciliar e, desde o deferimento da tutela de urgência, em 2019, sempre teria se dirigido ao hospital da parte recorrida para a aplicação do fármaco.
Destaca que a dignidade da pessoa humana e os direitos à vida e à saúde são

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

direitos fundamentais e assevera que o caso em apreço e o seu perfil como consumidor se coadunariam com os critérios estabelecidos nos §§ 12 e 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/1998.

Pondera que "[...] os interesses financeiros de uma gigante do segmento seguro/plano de saúde não podem prevalecer em detrimento da saúde de um cidadão" (fl. 577).

Pugna pela concessão de tutela de urgência, a fim de "evitar o retrocesso do tratamento, bem como quedas fatais, haja vista, ser deficiente visual e físico" (fl. 579).

Requer, ao final, a admissão do recurso e a remessa ao Supremo Tribunal Federal.

As contrarrazões foram apresentadas (fls. 636-641).

É o relatório.

Verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da obrigatoriedade de custeio de medicamento para tratamento de saúde no âmbito domiciliar, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (fls. 500-505):

Cinge-se a controvérsia em verificar se o medicamento DESONUMABE (Prolia), prescrito para tratamento de osteoporose, deve ser custeado pelo plano de saúde.

No presente caso, as instâncias ordinárias julgaram os pedidos iniciais procedentes, concluindo pela ilicitude da recusa da cobertura do medicamento com fundamento na ausência de previsão no rol da ANS e, consequentemente, pela obrigatoriedade de custeio do medicamento, condenando a operadora ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão:

[...] Sobre a questão, conforme o atual entendimento desta Corte Superior, é lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esse fim.

Nesse sentido:

[...] Ainda sobre a questão, esta Corte entende que o medicamento para tratamento domiciliar de que trata o art. 10, VI, da Lei 9.656/98, é aquele prescrito pelo médico e que deve ser adquirido diretamente nas farmácias e autoadministrado pelo paciente, portanto sem necessidade de supervisão direta de profissional habilitado em saúde para sua administração, e cuja indicação não tenha por fim substituir o tratamento ambulatorial ou hospitalar, nem esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente da Segunda Seção:

[...] É certo que, em que pese seja lícita a exclusão, a previsão legal do art. 10, VI, da Lei 9.656/98 não impede o custeio de medicação de uso domiciliar nos casos em que a operadora do plano de saúde o faz por liberalidade, por meio de previsão expressa no contrato principal do próprio

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

plano de saúde ou, ainda, mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN nº 310/2012 da ANS (REsp 1.692.938/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 4/5/2021).

No presente caso, contudo, conforme expressamente apontado pelo acórdão recorrido, o contrato firmado pelas partes prevê expressamente a exclusão de cobertura de medicamentos para uso domiciliar, bem como o medicamento prescrito pelo médico assistente da agravante é um fármaco que pode ser adquirido diretamente pelo paciente em farmácias de acesso ao público para autoadministração em seu ambiente domiciliar - via subcutânea (fls. 36/37), fora do ambiente hospitalar e ambulatorial, de modo que, não sendo obrigatório seu custeio pelo plano de saúde, não se afigura indevida, portanto, a negativa de cobertura.

Portanto, estando o entendimento do Tribunal de origem em confronto com a jurisprudência atual e específica desta Corte Superior acerca da matéria, **merece reforma o acórdão recorrido.**

Desse modo, a análise da matéria ventilada depende do exame do art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998, motivo pelo qual eventual ofensa à Constituição da República, se houvesse, seria reflexa ou indireta, não legitimando a interposição do recurso.

Em caso semelhante assim já decidiu a Suprema Corte:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR. COBERTURA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AI n. 868.063-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 15/10/2018, DJe de 24/10/2018.)

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário, ficando prejudicada a análise do pedido de tutela de urgência.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 08 de novembro de 2023.

MINISTRO OG FERNANDES

Vice-Presidente

(RE nos EDcl no REsp n. 1.982.152, Ministro Og Fernandes, DJe de 13/11/2023.) – trechos destacados

Logo não é possível impor-se ao réu a obrigação de fazer postulada, já que não há obrigação contratual e legal nesse sentido. Conclui-se, a partir de todo o exposto, que não houve ilicitude na recusa na prestação de serviços, o que afasta a procedência dos pedidos da parte autora.

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.

III) DISPOSITIVO

Ante ao exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Élida Maria Jardim Teodoro contra Unimed Rio Branco - Cooperativa de Trabalho Médico, fazendo isto com fundamento na Lei nº 9.656/98.

Declaro a extinção do processo, com análise do mérito (art. 487, I, CPC).

Diante da sucumbência, condeno a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 85, §2º CPC). Para tanto, levo em consideração a simplicidade da causa, a rápida tramitação, a revelia e o alto zelo do profissional que nela atuou. Suspendo a exigibilidade, eis que se trata de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Publique-se. Intimem-se. Ao final, em não havendo outras solicitações, arquivem-se.

Rio Branco-(AC), 04 de outubro de 2024.

Leandro Leri Gross
Juiz de Direito

Endereço: Rua Benjamin Constant, 1165, Centro - CEP 69900-064, Fone: (68) 3212-8448, Rio Branco-AC - E-mail: vaciv3rb@tjac.jus.br - Mod. 500076 - Autos n.º 0715595-88.2023.8.01.0001

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por LEANDRO LERI GROSS, liberado nos autos em 04/10/2024 às 12:10 .
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjac.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0715595-88.2023.8.01.0001 e código 5tuQAbdo.